



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : ولاء عبدالمعبود علي محمد
المحافظة : القليوبية الحي / المدينة : قليوب
رقم البطاقة : 28206271400988 رقم التليفون : 01280874365
العمر (تاريخ الميلاد) : 27-06-1982 المهنة : ربه منزل
العنوان : ميت نما
تاريخ تسجيل الإستمارة : 04-10-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه أنني لا اتمتع بأي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات أو أي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني الوظيفة : ----- التوقيع : -----
الاسم : د/ندى حسن الوظيفة : ----- التوقيع : -----
الاسم : د/نرمين رمضان الوظيفة : ----- التوقيع : -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : ----- قسم : -----
جهة العلاج : ----- نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: ولاء عبدالمعبود علي محمد National ID: 28206271400988	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

B 200

جمهورية مصر العربية
بكالوريوس الحقوق الشخصية

علام

عبدالمعز علي محمد علم الدين

ميت فسا

مركز قنوب - القليوبية

١٩٨٢/٠٦/٢٧

٢٨٢٠٦٢٧١٤٠٠٩٨٨

KG3491243

Name: ولاء عبد المعبود على		
MR. : 1030		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالتها		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها The patient’s tumor was documented as estrogen receptor (ER) 8/8, progesterone receptor (PR) 8/8, and HER2 negative. Following neoadjuvant chemotherapy (POST NACTH), the patient underwent radiation therapy after breast-conserving surgery (RT BCS) with pathology indicating PTIS PNIS M0. Multidisciplinary team discussion in February 2022 recommended a regimen of PORTH, ZOLADEX, and TAMOXIFEN; the patient is currently receiving ZOLADEX and TAMOXIFEN. A pelvic-abdominal ultrasound performed in April 2026 was reported as free of abnormal findings. A sonomammography for tamoxifen monitoring (3 months) and supportive care (3 months) remains pending. The patient is scheduled for the next follow-up visit in five weeks.		
تحريراً في ,		
	التاريخ :	18-09-2026
	الوقت :	نهى سعيد علي محمد
الطبيب المعالج :		
يعتمد ,		

Patient Name : الأستاذ / ولاء عبدالمعبود على محمد علم الدين	Request No. : 13004076
Patient No. : 28206271400988	Request Date : 05/12/2022
Path No. :	Verification Date : 18/12/2022
Sex : Female	Financial Category : اورام دار السلام - مبانزه
Age : 40 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.

Nature of the specimen: Right BCS and Right SLNs biopsy.

Gross Examination:

- Procedure: Right breast coservative surgery specimen; measured 10.5x7x3 cm, Covering nipple and areola measured 4x2 cm.
- Tumour extent : An ll defined rubbery grayish white tumor bed site
- Size: 5x3x2 cm
- Distance from margins: 3 cm from lateral and medial margins, 0.4 cm from deep margin (least).
- Lymph nodes number and size: Four nodules up to 1x1 cm
- Frozen section: Free margins, One lymph node suspicious for micrometastasis.

Microscopic examination.

- Histological type: Ductal carcinoma insitu, no invasive component
- Angioinvasion: Negative
- Lymph node involvement: One positive for micrometastasis
- Resection Margins: Free
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response
- Additional pathologic findings: Free nipple and areola

Diagnosis:

Right breast cancer; Right BCS and SLNs biopsy:

- Ductal carcinoma insitu, with no invasive component
- Free nipple and areola
- Free surgical margins
- One lymph node shows micrometastasis

Verified by :

dr.esra a magdy

Printing Date : 20/12/2022 09:24:38

Page 1 of 2

Printing By : marwa mohamed youss

Patient Name : الأستاذة / ولاء عبدالمعبود على محمد علم الدين	Request No. : 13004076
Patient No. : 28206271400988	Request Date : 05/12/2022
Path No. :	Verification Date : 18/12/2022
Sex : Female	Financial Category : مبادرات - مبادرات
Age : 40 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : .marwa mohamed youss

Pathology Report

- Partial pathologic response
- ypTis ypN1mi ypMx

Prof.Dr.Manal Elmahdy
Dr.Israa Elgendy

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 20/12/2022 09:24:38

Page 2 of 2

Printing By : .marwa mohamed youss



Patient Name	: الأستاذة / ولاء عبدالمعبود علي محمد علم الدين	Request No.	: 13008217
Patient No.	: 28206271400988	Request Date	: 18/04/2022
Path No.	: 1040/2022	Verification Date	: 10/05/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام نادر السلام - مياطرة
Age	: 40 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: dr.Enas

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:

Right breast UOQ lesion.

Nature of the specimen:

Tru cut biopsy, collected 17/4/2022, 11:10 AM.

Gross Examination:

- Multiple grayish white tissue cores up to 1 cm, totally submitted.
- Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): II(3+2+2)
- With DCIS component
- Biomarkers:

ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (Allred score 8/8)

PR: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (Allred score 8/8)

Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)

Ki 67: 15 % nuclear reaction

Diagnosis:

Right breast lesion; Tru cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, grade II
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).
- HER-2: Negative (score 0).

Verified by :

walaa ghoniem

Printing Date : 14/05/2022 09:43:49

Page 1 of 2

Printed By : Ali mostafa



Patient Name: Walaa Abdel Ma'boud Ali Mohamed	Date : 23/04/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 1793/2022	Pat. ID: 13113

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

- Reported case of operated breast cancer.
- Compared to the previous study dated 30-3-2023.

Chest:

- Right breast & axillary operative beds showing no sizable masses or sizable axillary lymph nodes.
- Still noted right upper lung lobe posterior segment pulmonary nodule with internal calcification, mostly representing post granulomatous sequel.
- Currently noted right upper lobe and middle lobe fine subpleural reticulations, likely post therapeutic sequel.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

Abdomen and pelvis:

- The liver is still moderately enlarged with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
- IUD is seen.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic masses or collections.

The scanned skeleton:

- Stable L2 small and right iliac tiny lytic osseous lesions.



Total DLP (mGy.cm):

Patient Name: Walaa Abdel Ma'boud Ali Mohamed	Date : 23/04/2024
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 41 Year(s)
Medical ID: 1793/2022	Pat. ID: 13113

- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- Right breast & axillary operative beds showing no sizable masses or sizable axillary lymph nodes.
- Rather stationary rest of the study.
- No definite pulmonary or hepatic metastatic deposits.

Dr. Ali Elsisy, MSc.

Signature Dr. Mohamed Mohsen

29/04/2024 08:46



Patient Name: Walaa Abdel Ma'boud Ali Mohamed	Date : 12/09/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 42 Year(s)
Medical ID: 1793/2022	Pat. ID: 13113

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had rt CBS

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)
- No left breast suspicious mass lesions, micro calcifications or architectural distortion detected.
- Right breast focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific left axillary LN, with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Asmaa Zenhom

12/09/2024 3:10 PM



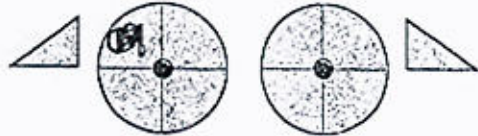
مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستراتيجية
صحة
مصر

MDT FORM 24/11/2022 G

Name	محمد عبد الحليم	MRN	1493155
Age	40 y	ID	CAC-76715599A
Menopausal status		Phone	0158.176370
NRS SCORE	1	Marital status	0187.47997
BMI	over weight	Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	

Clinical Data

BX:	IDC			R	L
ER:	2/4	PR:	2/4	HER 2:	-ve
Ki67:	15%				
Sonomammography:	CT3 No				
Mets Workup:				yctNM0	

Recommendations:

elad LAC - uterus bce bot 7/11/22
Planned Rt skin spx planned SLND
for MDT → JWS

MDT OUTCOME & PLAN

For upper Quadrantectomy +
Reconstruction by mini LD
+ SLND

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
JWS	[Signature]	[Signature]		[Signature]	